

Protocolos esenciales

Los seis que más tiempo te devuelven, ya
redactados

farmapro®

Que la farmacia funcione igual **esté quien esté.**

Acompaña la Edición #26 de farmapro Impulso. Los seis protocolos vienen redactados: no hay que empezar de cero, hay que adaptarlos. Donde veas una línea en blanco va lo que es vuestro (nombres, importes, plazos, sitios). Imprímelos, corrígelos con el equipo y deja cada hoja donde ocurre el proceso. **No los escribáis todos de golpe:** empezad por el que más veces te sacó de lo que estabas haciendo la semana pasada.

00	El método	03
	Anatomía de un protocolo que cabe en una hoja	
01	Recepción de pedido y faltas	04
	Lo que entra, lo que no viene y quién avisa	
02	La consulta que sube al farmacéutico	05
	Cuándo se deriva y cómo se hace delante del cliente	
03	Queja o devolución	06
	El margen de decisión del mostrador	
04	Caducidades y producto parado	07
	El que más dinero recupera de los seis	
05	Apertura y cierre	08
	Las dos rutinas más repetidas de la farmacia	
06	Acogida de una persona nueva	09
	El que hace que los otros cinco se transmitan solos	
07	El séptimo lo escribís vosotros	10
	El método en cinco pasos y el seguimiento	

Un protocolo útil **cabe en una hoja.**

Aquí se tuerce la mayoría de los intentos: «protocolo» suena a manual de calidad de ochenta páginas y, como suena a eso, no se empieza nunca. Uno que sirve tiene cinco cosas, y ninguna ocupa más de dos líneas.

LA PIEZA	QUÉ ESCRIBIR
Un disparador	Cuándo se aplica, dicho en lenguaje de mostrador. No «gestión de reclamaciones», sino «un cliente devuelve algo o se queja de algo que compró aquí».
Cinco a ocho pasos	En orden y en verbos. Si necesitas más de ocho, casi siempre hay dos protocolos metidos en uno.
Un responsable y un suplente	Quién lo hace por defecto y quién lo hace si esa persona no está. La segunda parte es la importante y es la que casi nunca se escribe.
Un criterio de decisión	El «hasta aquí decides tú»: hasta qué importe se resuelve sin consultar, en qué casos sube al farmacéutico. Sin esta línea el protocolo no libera tiempo, porque la consulta acaba llegando igual.
Una excepción declarada	Qué hacer cuando el caso no encaja. Un protocolo que no admite excepciones se incumple con la primera y a partir de ahí deja de existir.

Se estandariza el proceso, nunca el trato. Un protocolo no es un guion para hablar con el cliente ni una forma de quitar criterio a nadie: define qué pasos se dan, no cómo se atiende. El trato es justo lo que diferencia a vuestra farmacia.

EVITAD ESTO

Las cuatro formas de matar un protocolo

Escribirlos todos de golpe (la energía se agota en el tercero y el resto nace muerto) · Escribirlos solo el titular (nadie defiende lo que no ha ayudado a redactar) · No revisarlos nunca (en seis meses el papel dice una cosa y la farmacia hace otra, y el equipo aprende que el papel no manda) · Usarlos para señalar culpables (en cuanto sirven para reprochar, dejan de ser herramienta y pasan a ser expediente).

Lo que entra, lo que no viene **y quién avisa.**

Disparador: llega el pedido del almacén o del laboratorio.

LOS PASOS

ADAPTAR A VUESTRA FARMACIA

1. Comprobar el albarán contra lo que hay en la caja antes de guardar nada.
2. Anotar en el mismo momento lo que no ha venido o viene mal, en _____ (sitio único, siempre el mismo).
3. Comprobar si alguna falta corresponde a un cliente que la está esperando.
4. Avisar a ese cliente en un plazo máximo de _____, por el canal habitual.
5. Reclamar la falta al proveedor o pasarla al siguiente pedido, según lo que se haya acordado.
6. Colocar el producto y dejar registrada la incidencia como cerrada.

Responsable por defecto

El puesto de _____ en el turno de recepción.

Si esa persona no está

_____ asume la comprobación y el aviso al cliente.

Criterio de decisión

Hasta _____ euros de diferencia se resuelve en el momento sin consultar. Por encima, se avisa al titular antes de aceptar el albarán.

Excepción declarada

Si el pedido llega en hora punta, se comprueba solo lo urgente y de frío; el resto queda pendiente y se anota la hora en que se completa la revisión.

El fallo típico no es no revisar: es que la falta se anote en un sitio distinto cada vez. Elegid uno y que sea el mismo siempre, aunque sea una libreta.

Cuándo se deriva, y cómo **delante del cliente.**

Disparador: en el mostrador aparece una consulta que no se puede resolver ahí.

LOS PASOS

ADAPTAR A VUESTRA FARMACIA

1. Identificar el caso: si entra en la lista de derivación obligatoria de abajo, se deriva sin valorarlo.
2. Decírselo al cliente como lo que es, un plus y no un problema: «esto lo ve el farmacéutico, que es quien lo lleva».
3. Llamar al farmacéutico por el canal acordado (_____), nunca gritando desde el mostrador.
4. Resumirle el caso en una frase: quién, qué pide y qué se le ha dicho ya.
5. Acompañar al cliente mientras espera; si la espera pasa de _____ minutos, ofrecer alternativa.
6. Registrar la consulta si el caso lo requiere, según lo que tengáis establecido.

Responsable por defecto

Quien esté en el mostrador en ese momento.

Si esa persona no está

Si el farmacéutico responsable no está: _____.

Criterio de decisión

Derivación obligatoria en: _____ (por ejemplo, interacciones, embarazo y lactancia, pediatría, síntomas de alarma, medicación crónica). Fuera de esa lista, decide quien atiende.

Excepción declarada

Si no hay farmacéutico disponible en ese momento, se toman los datos del cliente y se le llama antes de _____. Nunca se improvisa la respuesta.

La lista de derivación obligatoria es la parte que hay que escribir sí o sí. Sin ella, cada persona pone el listón donde le parece, y ahí es donde el criterio deja de ser el de la farmacia.

Hasta dónde decide **quien está delante.**

Disparador: un cliente devuelve un producto o se queja de algo que compró aquí.

LOS PASOS

ADAPTAR A VUESTRA FARMACIA

1. Escuchar entera la queja sin interrumpir y sin justificar todavía.
2. Repetir el problema con vuestras palabras para confirmar que se ha entendido.
3. Comprobar los datos que hagan falta (ticket, fecha, lote, estado del producto).
4. Resolver en el momento si entra dentro del criterio de abajo.
5. Si no entra, decir con claridad qué va a pasar y cuándo: quién le llamará y en qué plazo.
6. Anotar la queja en _____, con una línea sobre qué la provocó.
7. Revisar esas anotaciones una vez al mes: lo que se repite no es mala suerte, es un proceso que falla.

Responsable por defecto

Quien atiende al cliente en ese momento.

Si esa persona no está

Casos que superen el criterio: _____.

Criterio de decisión

Hasta _____ euros se resuelve en el momento sin consultar a nadie (cambio, abono o vale, según proceda).

Excepción declarada

Producto de frío, medicamento dispensado o cualquier caso con implicación sanitaria: no se acepta la devolución y se explica el motivo. Si el cliente insiste, pasa al farmacéutico.

El importe del criterio es la línea que más tiempo devuelve al titular. Si no está escrito, todas las quejas acaban subiendo, incluidas las de tres euros.

El protocolo que **más dinero recupera.**

Disparador: llega la fecha fija de revisión (día _____ de cada mes).

LOS PASOS

ADAPTAR A VUESTRA FARMACIA

1. Revisar la zona que toque este mes según el reparto acordado, no la farmacia entera.
2. Sacar lo que caduca en los próximos _____ meses y dejarlo en el sitio acordado (_____).
3. Comprobar qué producto no ha rotado en los últimos _____ meses.
4. Decidir por cada referencia: devolver al proveedor, promocionar, mover de sitio o retirar.
5. Aplicar la decisión esa misma semana; lo que se aplaza, se pierde.
6. Avisar al equipo de lo que se ha puesto en promoción o ha cambiado de sitio.
7. Anotar qué se ha recuperado, para saber si la revisión merece la pena tal y como está montada.

Responsable por defecto

El puesto de _____, con la zona asignada del mes.

Si esa persona no está

_____ si esa persona está de vacaciones o de baja.

Criterio de decisión

Devoluciones y cambios de ubicación se deciden en el mostrador. Descuentos por encima del _____ por ciento los aprueba el titular.

Excepción declarada

Producto en promoción activa o de temporada: no se retira hasta que termine la campaña, aunque cumpla el criterio de parado.

Por zonas y con fecha fija. «Revisar caducidades» sin trocear el trabajo se convierte en una tarea que siempre empieza el mes que viene.

Las dos rutinas **más repetidas** de la farmacia.

Disparador: primera y última media hora del día. Son las que más se hacen «cada uno a su manera».

APERTURA

MARCAR CADA DÍA

1. Encender sistemas y comprobar que el programa de gestión y el datáfono responden.
2. Revisar la temperatura de las neveras y anotarla en _____.
3. Comprobar el cambio de la caja y dejarlo cuadrado.
4. Recoger avisos y encargos pendientes del día anterior y repartirlos.
5. Repasar el escaparate y la zona de entrada: limpio, con la campaña vigente y sin material caducado.
6. Reparto rápido del día: quién está en mostrador, quién en pedidos, quién libra.

CIERRE

MARCAR CADA DÍA

1. Cuadrar la caja y dejar el cambio preparado para el día siguiente.
2. Dejar anotado lo pendiente: encargos, faltas, clientes a los que hay que llamar.
3. Comprobar que no queda producto de frío fuera de la nevera.
4. Repasar neveras, alarmas y luces según _____.
5. Dejar el mostrador despejado para que la apertura empiece limpia.

Esta hoja va plastificada donde ocurre, no en una carpeta. Responsable de apertura: _____ · de cierre: _____. Y una casilla al lado de cada línea: lo que se marca, se hace.

El protocolo que hace que los otros cinco se transmitan solos.

Disparador: se incorpora alguien nuevo, sea fijo, sustituto o de temporada.

LOS PASOS

ADAPTAR A VUESTRA FARMACIA

1. Antes del primer día: elegir persona de referencia y avisar al equipo de quién llega y a qué.
2. Día 1: presentación real (quién es quién y qué lleva cada uno), horarios, descansos y dónde está todo.
3. Día 1: entregarle los protocolos de esta guía que le afecten y explicarle dónde vive cada hoja.
4. Semana 1: trabajo en sombra junto a la persona de referencia, sin atender sola.
5. Semana 2: primeras atenciones acompañadas y quince minutos de feedback, que no es un juicio.
6. Semana 3: atiende sola con apoyo a mano y asume una responsabilidad propia.
7. Semana 4: evaluación en las dos direcciones y objetivos para los siguientes sesenta días.

Responsable por defecto

La persona de referencia: _____.

Si esa persona no está

El titular asume el día 1 y la conversación de la semana 4 si la referencia no está.

Criterio de decisión

La persona nueva atiende sola a partir de _____, salvo los casos de derivación obligatoria del protocolo 02.

Excepción declarada

En incorporaciones de refuerzo puntual (menos de un mes), se aplican solo los pasos 1, 2, 3 y 4.

La persona de referencia no es quien tenía hueco esa semana: es alguien a quien el equipo reconoce como referente. El plan completo de los primeros 30 días está en el descargable de la Edición #25.

Y el método es **no escribirlo tú.**

Los seis anteriores cubren la mayoría de las interrupciones evitables, pero cada farmacia tiene el suyo. Este es el método completo, y cuesta menos de una hora repartida en dos semanas.

PASO 1 Elegid el proceso que más interrumpe

No el más importante en abstracto: el que más veces te sacó de lo que estabas haciendo la semana pasada.

PASO 2 Que lo escriba quien lo hace

Veinte minutos, una hoja, los pasos tal y como se hacen hoy. No como deberían hacerse. Un protocolo redactado por el titular en su despacho describe una farmacia ideal que no existe, y por eso no se cumple.

PASO 3 Corregidlo en equipo en quince minutos

Ahí salen las discrepancias interesantes, del tipo «ah, ¿tú eso lo haces así?». Esa conversación vale más que el documento.

PASO 4 Añade tú el criterio y la excepción

Es la parte del titular, y es la que convierte una descripción en un protocolo.

PASO 5 Probadlo dos semanas y ponedle fecha de revisión

Un protocolo es un borrador permanente. La fecha desde el primer día evita que envejezca y que alguien lo declare inútil por una sola línea desactualizada.

El seguimiento es la mitad que casi siempre falta. Dos minutos al mes con la hoja de cálculo que acompaña a esta guía: no para vigilar a nadie, sino para detectar cuál de los protocolos hay que reescribir porque la realidad ya no cabe dentro.



farmapro®

Sobre farmapro:

farmapro es el ecosistema digital de referencia para farmacias en España. En los últimos 15 años hemos ayudado a más de 500 titulares a impulsar su farmacia, ordenar su gestión y hacer crecer su equipo.

Si quieres acompañamiento para poner orden en la gestión de tu farmacia, escríbenos:

somos@farmapro.es

© *farmapro impulso* | Todos los derechos reservados

605 87 57 01 | somos@farmapro.es

farmapro.es | @farmapro.official

